==========

==========

仁爱医院健康体检中心

体检报告编号：20241015-0089

==========

==========

【基本信息】
姓名：李秀英
性别：女

年龄：67 岁

民族：回族

出生日期：1957 年 03 月 12 日

身份证号：410**********

联系电话：138****5678

体检日期：2024 年 10 月 15 日

==========

==========

【主检报告】
体检结论：

1. 高血压病 3 级（高危组）

2. 2 型糖尿病（空腹血糖 7.8mmol/L，餐后 2h 血糖 11.2mmol/L）

3. 肺结节（右肺上叶混合磨玻璃结节，直径 12mm，建议增强 CT）

4. 颈动脉斑块形成（右侧颈总动脉 IMT 1.4mm，可见混合回声斑块）

5. 骨质疏松（T 值-2.8）

6. 认知功能轻度下降（MMSE 22/30，教育程度小学）

健康建议：

1. 低盐低脂糖尿病饮食

2. 规律服用降压降糖药物

3. 呼吸科门诊随访（3 个月复查 CT）

4. 神经内科认知评估

==========

==========

【一、体格检查】

身高：158cm

体重：68kg

腰围：86cm

臀围：94cm

BMI：27.2（超重）

血压：168/96 mmHg（坐位，右上肢）

心率：88 次/分，律齐

体温：36.5℃

呼吸：20 次/分

【内科检查】
神志清楚，查体合作。

皮肤黏膜无黄染，全身浅表淋巴结未触及肿大。
双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。

心前区无隆起，心尖搏动位于第 5 肋间左锁骨中线内 0.5cm，心率 88 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

腹部平坦，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，肠鸣音 4 次/分。

双下肢无水肿。

【外科检查】
脊柱四肢无畸形，活动自如。
双乳对称，未触及肿块及结节。
肛门外生殖器未查。

【眼科检查】

视力：右眼 0.6，左眼 0.5（矫正）

眼底：双眼动脉变细，反光增强，可见动静脉交叉压迫征（高血压视网膜病变Ⅱ级）

眼压：右眼 16mmHg，左眼 15mmHg

【耳鼻喉科】
外耳道通畅，鼓膜完整，粗测听力正常。
鼻腔通畅，鼻中隔居中。
咽部无充血，扁桃体无肿大。

==========

==========

【二、实验室检查】

【血常规】

白细胞（WBC）：6.8 ×10^9/L（参考：3.5-9.5）

红细胞（RBC）：4.52 ×10^12/L（参考：3.8-5.1）

血红蛋白（HGB）：135 g/L（参考：115-150）

血小板（PLT）：245 ×10^9/L（参考：125-350）

中性粒细胞百分比：62.3%（参考：40-75）

淋巴细胞百分比：28.5%（参考：20-50）

【肝功能】

丙氨酸氨基转移酶（ALT）：45 U/L（参考：7-40）↑

天门冬氨酸氨基转移酶（AST）：38 U/L（参考：13-35）↑

γ-谷氨酰转肽酶（GGT）：68 U/L（参考：7-45）↑

总胆红素（TBIL）：12.5 μmol/L（参考：3.4-20.5）

直接胆红素（DBIL）：3.2 μmol/L（参考：0-6.8）

【肾功能】

尿素氮（BUN）：7.2 mmol/L（参考：3.2-7.1）↑

肌酐（Cr）：82 μmol/L（参考：44-104）

尿酸（UA）：485 μmol/L（参考：155-357）↑

估算肾小球滤过率（eGFR）：72 mL/min/1.73m²（参考：>90）↓

【血脂全套】

总胆固醇（TC）：6.28 mmol/L（参考：<5.2）↑

甘油三酯（TG）：2.65 mmol/L（参考：<1.7）↑

高密度脂蛋白（HDL-C）：0.98 mmol/L（参考：>1.0）↓

低密度脂蛋白（LDL-C）：3.92 mmol/L（参考：<3.4）↑

载脂蛋白 A1：1.15 g/L（参考：1.0-1.6）

载脂蛋白 B：1.32 g/L（参考：0.6-1.1）↑

【糖代谢】

空腹血糖（FBG）：7.8 mmol/L（参考：3.9-6.1）↑

餐后 2 小时血糖：11.2 mmol/L（参考：<7.8）↑

糖化血红蛋白（HbA1c）：7.2%（参考：4.0-6.0）↑

空腹胰岛素：15.6 mIU/L（参考：2.6-24.9）

【尿常规】

尿蛋白（PRO）：+（0.3g/L）

尿糖（GLU）：-

尿酮体（KET）：-

尿潜血（BLD）：-

尿比重（SG）：1.020（参考：1.003-1.030）

尿 pH：6.0

镜检：未见明显异常

【肿瘤标志物】

癌胚抗原（CEA）：3.2 ng/mL（参考：<5.0）

甲胎蛋白（AFP）：2.8 ng/mL（参考：<7.0）

神经元特异性烯醇化酶（NSE）：15.6 ng/mL（参考：<16.3）

细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）：3.8 ng/mL（参考：<3.3）↑

【甲状腺功能】

促甲状腺激素（TSH）：2.85 mIU/L（参考：0.35-4.94）

游离 T3（FT3）：4.52 pmol/L（参考：3.5-6.5）

游离 T4（FT4）：14.8 pmol/L（参考：11.5-22.7）

==========

【三、影像学检查】

【胸部 CT 平扫】

检查所见：

肺窗：双肺纹理增多紊乱。右肺上叶尖段可见一混合磨玻璃结节，大小约 12mm ×10mm，边缘可见毛刺征及分叶征，内部可见小空泡征。右肺中叶及左肺舌叶可见条索状高密度影。左肺下叶可见一纯磨玻璃小结节，直径约 5mm，边界清晰。

纵隔窗：纵隔居中，气管及主支气管通畅。隆突下及右肺门可见小淋巴结，短径约 8mm。心脏不大，主动脉及冠状动脉可见钙化斑块。

胸腔：双侧胸腔未见积液。

诊断意见：

1. 右肺上叶混合磨玻璃结节（12mm），具有恶性特征（毛刺征、分叶征、空泡征），Lung-RADS 4B 类，建议 PET-CT 或穿刺活检。

2. 左肺下叶纯磨玻璃小结节（5mm），Lung-RADS 2 类，建议年度随访。

3. 肺气肿改变。

4. 主动脉及冠状动脉硬化。

【颈部血管超声】
检查所见：
双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉走行正常。

右侧颈总动脉分叉处后壁可见混合回声斑块，大小约 15.6mm×3.2mm，局部管腔狭窄约 45%。

左侧颈总动脉内膜增厚，IMT 1.2mm，未见明确斑块。

血流频谱：右侧颈内动脉收缩期峰值流速 98cm/s，舒张末期流速 32cm/s。

诊断意见：

1. 右侧颈总动脉斑块形成（混合回声，狭窄率 45%）

2. 左侧颈总动脉内膜增厚

3. 双侧颈动脉血流速度未见明显异常

【甲状腺超声】
检查所见：
甲状腺双侧叶及峡部大小形态正常。

左叶中部可见一低回声结节，大小约 8mm×6mm×7mm，边界清晰，形态规则，内部回声均匀，未见钙化，CDFI 示周边可见少许血流信号。

右叶未见明确结节。
颈部未见异常肿大淋巴结。

诊断意见：

甲状腺左叶结节，TI-RADS 3 类，建议年度随访。

【心脏超声】
检查所见：
各房室腔内径正常范围。

左室壁厚度正常，室间隔及左室后壁厚度约 10mm，左室射血分数 LVEF 65%。

二尖瓣、三尖瓣可见少量反流信号。

主动脉瓣回声增强，开放尚可。
肺动脉压正常。

诊断意见：

1. 左室舒张功能减退（E/A < 0.8）

2. 主动脉瓣退行性变

3. 二尖瓣、三尖瓣轻度反流

【骨密度测定（DXA）】

检查部位：腰椎 L1-L4、左髋部

腰椎 L1-L4：BMD 0.752 g/cm²，T 值 -2.8，Z 值 -1.2

左股骨颈：BMD 0.618 g/cm²，T 值 -2.5，Z 值 -0.9

诊断：骨质疏松

==========

==========

【四、慢病风险评估专项】

【心血管综合风险评估】

10 年 ASCVD 风险评分：23.5%（高危）

风险因素：年龄 67 岁、高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟（已戒烟 10 年）

【糖尿病并发症筛查】
视网膜病变：高血压视网膜病变Ⅱ级

肾病：尿蛋白+，eGFR 72（CKD 2 期）

神经病变：10g 尼龙丝试验（-），踝反射正常

【认知功能评估】

MMSE 得分：22/30

- 定向力：8/10（时间定向扣 1 分，地点定向扣 1 分）
- 记忆力：3/3
- 注意力和计算力：3/5（100-7 连续减 5，答错 2 次）
- 回忆能力：2/3（漏记 1 项）
- 语言能力：6/9（复述扣 1 分，阅读理解扣 1 分，书写扣 1 分）

MoCA 得分：19/30（<26，提示认知功能异常）

- 教育年限：6 年（小学文化），校正后加 1 分 → 20 分

临床印象：轻度认知障碍（MCI）

【营养评估】

MNA-SF 评分：10/14（营养不良风险）

==========

==========

【五、既往史与行为数据】

既往病史：

1. 高血压病史 15 年，最高 180/100mmHg，规律服用硝苯地平控释片 30mg qd，血压控制在 140-150/85-95mmHg

2. 2 型糖尿病病史 8 年，口服二甲双胍 0.5g bid，血糖控制欠佳

3. 高脂血症病史 5 年，服用阿托伐他汀 20mg qn

4. 否认肝炎、结核等传染病史

5. 否认手术外伤史

6. 否认食物药物过敏史

家族史：

父亲：高血压、脑卒中（72 岁去世）

母亲：2 型糖尿病、冠心病（80 岁健在）

妹妹：高血压、高脂血症

吸烟史：既往吸烟 30 年，每日 20 支，已戒烟 10 年（包年计算：20/20×30=30 包年）

饮酒史：不饮酒

生活习惯：

饮食：口味偏咸，喜食面食，蔬菜摄入不足

运动：每周散步 2-3 次，每次 30 分钟

睡眠：入睡困难，夜间易醒，睡眠质量差

社会心理：

退休教师，独居，子女在外地，社会支持较少

GAD-7 焦虑评分：6 分（轻度焦虑）

PHQ-9 抑郁评分：5 分（无明显抑郁）

==========

==========

【六、建议与随访计划】

立即处理：

1. 呼吸科门诊就诊，评估肺结节（建议增强 CT 或 PET-CT）

2. 调整降压药物，目标血压<130/80mmHg

3. 调整降糖方案，HbA1c 目标<7.0%

4. 加用抗血小板药物（阿司匹林 100mg qd）

3 个月随访：

1. 复查胸部 CT

2. 复查糖化血红蛋白、血脂全套

3. 24 小时动态血压监测

6 个月随访：

1. 复查颈动脉超声

2. 认知功能复查（MMSE/MoCA）

3. 骨密度复查

1 年随访：

1. 年度体检

2. 肿瘤标志物复查

==========

==========

体检报告结束

==========

==========